E

RECURSO PROFESIONAL · PARA FAMILIAS Y EDUCADORES

Guía de Tartamudez Infantil

Cómo acompañar a tu peque sin alarmismo · Basado en evidencia

Revisado por logopeda colegiada

Guía de Tartamudez Infantil

Comprende, acompaña y ayuda a tu hijo o hija con información basada en evidencia

Guía gratuita · Espacio Lenguaje · Logopedia infantil especializada

---

Índice de contenidos

1. Qué es la tartamudez (definición, tipos y mitos)
2. Disfluencia evolutiva vs patológica
3. Factores de riesgo de persistencia
4. Qué hacer y qué NO hacer en casa
5. Ejercicios y pautas ambientales para casa
6. Sección para profesores
7. Cuándo consultar con un logopeda
8. Recursos y dónde encontrar ayuda

Capítulo 1 · Qué es la tartamudez

La tartamudez es mucho más que "trabarse al hablar". Antes de cualquier decisión, conviene entender qué ocurre realmente y separar los datos de los mitos.

Definición

La tartamudez (o disfemia) es un **trastorno del neurodesarrollo de la fluidez del habla** que se caracteriza por interrupciones involuntarias en el flujo del discurso. No se trata de un problema de pensamiento, ni de timidez, ni de "nervios": tiene una **base neurobiológica y un componente genético** bien documentados (Yairi & Ambrose, 2013; Guitar, 2019).

Estas interrupciones pueden adoptar distintas formas, y la combinación de ellas nos orienta sobre la gravedad.

Tipos de disfluencia típicos de la tartamudez

Tipo	Qué ocurre	Ejemplo
Repeticiones de sonido/sílaba	Se repite un sonido o una sílaba varias veces	"m-m-m-mamá" / "ma-ma-mamá"
Prolongaciones	Un sonido se alarga de forma involuntaria	"mmmmira" / "sssssilla"
Bloqueos	El sonido no sale; hay silencio con tensión audible o visible	".....pero yo quiero ir"
Mixta	Combinación de repeticiones, prolongaciones y bloqueos	"Pe-pe-.....pero yo quiero ir"

Las **repeticiones de palabra entera** ("yo-yo quiero ir") también son disfluencias, pero se consideran dentro de lo típico del desarrollo, no signos de tartamudez (Yairi & Ambrose, 1999). Más detalle en el Capítulo 2.

Datos clave

- **Prevalencia a lo largo de la infancia: ~5%** de los niños y niñas pasarán por un episodio de tartamudez en algún momento de su desarrollo (Yairi & Ambrose, 2013; Reilly et al., 2009).
- **Recuperación espontánea: aproximadamente el 75–80%** de los niños que empiezan a tartamudear entre los 2 y los 5 años recuperan la fluidez sin intervención directa, habitualmente en los 12–36 meses siguientes al inicio (Yairi & Ambrose, 1999, 2005). Esto significa que **1 de cada 5** mantendrá la tartamudez si no se interviene.
- **Prevalencia en adultos: ~1%** de la población adulta mantiene la tartamudez.
- **Ratio por sexo: 3:1 a 4:1** a favor de niños respecto a niñas. Los chicos también tienen menor probabilidad de recuperación espontánea.
- **Edad de inicio típica: entre los 2 y los 5 años**, coincidiendo con la explosión del lenguaje.
- **No la causa el nerviosismo** ni un trauma emocional, aunque el estrés pueda ser desencadenante en niños ya predispuestos.

> **Clave que conviene retener:** una mayoría de niños supera la tartamudez sin tratamiento directo, pero esa mayoría no incluye a todos. La pregunta útil no es "¿se le pasará?", sino "¿tiene mi hijo/a factores de riesgo que aconsejen consultar ya?". Lo vemos en el Capítulo 3.

¿Qué pasa en el cerebro?

Estudios de neuroimagen muestran diferencias en la conectividad entre las áreas cerebrales responsables de **planificar** el habla y las que **ejecutan** los movimientos articulatorios. Es como si la "autopista" entre la idea y los músculos del habla tuviera un tramo de obras: la información llega, pero con microinterrupciones. Esta base neurológica explica por qué las órdenes del tipo "respira y habla despacio" no resuelven el problema: no se trata de voluntad.

Mitos frecuentes que conviene desmontar

- **"Tartamudea porque es nervioso."** Falso. La tartamudez tiene base neurológica y genética. La ansiedad puede empeorarla pero no la causa.
- **"Si le digo que respire hondo y hable despacio, se le pasará."** Falso y contraproducente. Esas instrucciones aumentan la autoconciencia y la tensión, y empeoran la tartamudez (Guitar, 2019).
- **"Es por un susto o un trauma."** Falso. El estrés puede actuar como desencadenante en un niño ya predispuesto, pero no es la causa.
- **"Se le pasará solo."** A veces sí (75–80% de los casos), pero no siempre. Si persiste más de 6–12 meses o hay factores de riesgo, conviene consultar.
- **"Los niños que tartamudean son menos inteligentes."** Completamente falso. No existe ninguna relación entre tartamudez e inteligencia.

> **Genética:** la tartamudez se agrupa en familias. Si hay antecedentes (padre, madre, hermanos, tíos, abuelos), la probabilidad de que el niño tartamudee aumenta y, si ya tartamudea, la probabilidad de resolución espontánea es menor.

Capítulo 2 · Disfluencia evolutiva vs patológica

No toda disfluencia infantil es tartamudez. Entre los 2 y los 5 años, muchos niños pasan por una fase de habla entrecortada porque el lenguaje crece más rápido que su capacidad motora y de planificación. Esto es disfluencia evolutiva y suele resolverse sola. La clave está en **el tipo de disfluencia, la tensión y la reacción emocional** del niño.

Tabla comparativa

Aspecto	Disfluencia evolutiva	Tartamudez que necesita valoración
Edad de inicio	2–5 años	Cualquier edad; mayor alerta si inicio >3,5 años
Repetición de **palabra entera** ("yo-yo quiero")	Típico	—
Repetición de **sílaba** ("ma-ma-mamá")	Indicador intermedio: vigilar	Frecuente
Repetición de **sonido/fonema** ("m-m-m-mamá")	Poco frecuente	Señal de alerta
Prolongaciones ("mmmmira")	Raras	Habituales
Bloqueos con tensión (silencio tenso antes de la palabra)	Ausentes	Presentes
Tensión facial/corporal al hablar	No	Sí (cara, cuello, mandíbula)
Conciencia del problema	El niño no se da cuenta	El niño se da cuenta y se frustra
Duración	Episodios breves, <6 meses	Más de 6–12 meses
Conductas secundarias	No	Parpadeo, movimientos de cabeza, evitación
Evolución	Va y viene; mejora con el tiempo	Se mantiene o empeora
Reacción emocional	Ninguna o muy leve	Ansiedad, vergüenza, evita hablar

> **Regla orientativa:** si la disfluencia dura más de 6 meses, si aparecen repeticiones de sonido, prolongaciones o bloqueos con tensión, si el niño evita situaciones de habla, o si hay antecedentes familiares, **consulta con un logopeda especializado en fluidez**. Mejor consultar de más que de menos: la intervención temprana tiene los mejores resultados.

Conductas secundarias: señal de que la tartamudez se está consolidando

Las conductas secundarias son movimientos o estrategias que el niño desarrolla —a veces sin darse cuenta— para intentar "salir" del bloqueo. Cuando aparecen, significa que la tartamudez ya le está afectando emocionalmente:

- Parpadeo rápido o cierre de ojos durante los bloqueos.
- Movimientos de cabeza (hacia atrás, hacia los lados) para "empujar" la palabra.
- Tensión visible en labios, mandíbula o cuello.
- Cambio de palabras: sustituye la que le bloquea por otra ("sinónimo de rescate").
- Evitación: deja de hablar, responde con monosílabos, no participa en clase.
- Muletillas previas: "pues...", "eh...", "o sea..." para tomar impulso antes de la palabra difícil.

La presencia de conductas secundarias es uno de los motivos más claros para consultar sin esperar más.

Capítulo 3 · Factores de riesgo de persistencia

No todos los niños que empiezan a tartamudear mantendrán la tartamudez. Conocer los factores de riesgo ayuda a decidir si conviene esperar unos meses con pautas ambientales o iniciar una valoración cuanto antes (Yairi & Ambrose, 2005; Singer et al., 2020).

1. **Antecedentes familiares de tartamudez persistente.** Si algún familiar directo tartamudea (o tartamudeó de niño sin resolverse), el riesgo de persistencia aumenta significativamente.
2. **Sexo masculino.** Los niños tienen 3–4 veces más probabilidades que las niñas de tartamudear y menor probabilidad de recuperación espontánea.
3. **Duración mayor de 6–12 meses.** Cuanto más tiempo lleve el niño tartamudeando, menor es la probabilidad de resolución espontánea.
4. **Inicio después de los 3 años y medio.** Un inicio más tardío se asocia con mayor riesgo de persistencia.
5. **Otras dificultades del habla o lenguaje.** Dificultades articulatorias o de vocabulario/gramática aumentan el riesgo.
6. **Severidad creciente.** Si la tartamudez va a más en lugar de a menos en los meses siguientes al inicio, conviene intervenir.
7. **Aparición de conductas secundarias o evitación.** Ver Capítulo 2.
8. **Impacto emocional.** Si el niño ya se muestra frustrado, triste o se niega a hablar, no hay que esperar más.

> Estos factores son **orientativos, no deterministas**. Un niño puede no tener ningún factor y necesitar ayuda, u otros pueden tener varios y resolverlo solos. Ante la

duda, valoración profesional.

Capítulo 4 · Qué hacer y qué NO hacer en casa

El entorno familiar es una pieza central. La evidencia más sólida en tartamudez preescolar (programas **Lidcombe** y **Palin PCI**, que veremos en el Capítulo 5) se apoya en la idea de que **modificar cómo interactuamos con el niño es más eficaz que pedirle al niño que cambie cómo habla**. Tu forma de reaccionar puede ayudar mucho o, sin querer, empeorar la situación.

SÍ hacer

- **Mantén el contacto visual** mientras habla. Que sienta que le escuchas con interés.
- **Escucha con paciencia, sin prisa.** Deja que termine a su ritmo.
- **Habla tú más despacio.** Modela un ritmo tranquilo y pausas naturales, sin exagerar. El niño tenderá a igualarse.
- **Dale tiempo para terminar.** No interrumpas ni completes sus frases.
- **Reduce la presión comunicativa:** preguntas sencillas (sí/no, opciones), turnos claros, un interlocutor cada vez.

- **Valora el contenido, no la forma.** "Qué historia tan interesante" es más útil que "qué bien lo has dicho".
- **Crea un ambiente tranquilo para hablar:** sin ruido de fondo, sin prisas, sin interrupciones cruzadas entre hermanos.
- **Introduce momentos de conversación uno a uno al día**, breves (5–10 minutos) y sin pantallas.

NO hacer

- **No le digas "habla despacio", "respira hondo" o "piensa antes de hablar".** Aumentan la autoconciencia y la ansiedad, y empeoran la tartamudez. Es tú quien modela el ritmo, no él quien lo ejecuta conscientemente.
- **No termines sus frases.** Aunque creas que le ayudas, le transmite que su habla es un problema.
- **No apartes la mirada ni muestres impaciencia** (suspirar, mirar el reloj, fruncir el ceño).
- **No le hagas repetir.** "Dilo otra vez bien" es contraproducente.
- **No le pongas en evidencia** ni le obligues a hablar en situaciones que le generen ansiedad (recitar delante de visitas, leer en voz alta si se resiste).
- **No hables de la tartamudez negativamente delante de él** ni con otros cuando pueda oír.

> **La regla de oro:** que tu hijo/a sienta que **lo que dice importa más que cómo lo dice**. Si se siente escuchado y aceptado, la presión comunicativa baja y, con ella, la tartamudez.

Hablar de la tartamudez con tu hijo/a

Si el niño ya es consciente, evitar el tema le transmite que es algo vergonzoso. No hace falta usar la palabra "tartamudez" desde el primer día, pero sí se puede normalizar:

- **Si él lo saca:** "A veces las palabras se atascan, ¿verdad? A mucha gente le pasa. No pasa nada."
- **Normaliza:** "A mí también me pasa a veces, sobre todo cuando estoy cansado/a."
- **Empodera:** "Tu cerebro tiene muchísimas ideas y a veces la boca no va tan rápido."

¿Y los hermanos?

Explícales, adaptado a su edad, que a veces las palabras se atascan y que hay que tener paciencia. **No se toleran burlas ni imitaciones.** Involúcralos como aliados: "Cuando tu hermano/a esté hablando, le esperamos, ¿vale?"

Capítulo 5 · Ejercicios y pautas ambientales para casa

> **Advertencia importante antes de empezar: en menores de 5–6 años, el enfoque principal es ambiental, no técnicas directas de habla.** La evidencia actual (Onslow et al.; Kelman & Nicholas) recomienda programas como **Lidcombe** o **Palin PCI**, que modifican el entorno comunicativo y el feedback de los padres, en lugar de pedir al niño que "hable de una manera concreta". Las técnicas directas (habla prolongada, inicios suaves, etc.) son útiles **en niños más mayores y siempre dentro de un plan de intervención con un logopeda**, no como tarea para hacer en solitario con un preescolar.
>
> Las actividades que siguen se plantean como **juegos familiares de bajo estrés**, no como "entrenamiento del habla". Su objetivo es crear momentos de comunicación exitosa, no corregir la tartamudez.

Programas con evidencia (para que sepas qué existe)

- **Programa Lidcombe** (Onslow et al., Australia). Primera línea de tratamiento en **preescolares (2–6 años)** con evidencia alta. Los padres, entrenados por un logopeda, proporcionan en casa un feedback verbal contingente y estructurado durante juegos cotidianos. No se le pide al niño que cambie cómo habla.

- **Palin Parent–Child Interaction (Palin PCI)** (Kelman & Nicholas, Michael Palin Centre). Evidencia buena en **2–7 años**. Trabaja sobre la interacción padres–hijo: ritmo de habla, turnos, preguntas, tiempo de respuesta y confianza comunicativa. Muy adecuado cuando el componente ambiental pesa mucho.
- **RESTART-DCM** (Países Bajos). Enfoque de Demandas y Capacidades con evidencia creciente, que busca equilibrar lo que se le pide comunicativamente al niño con lo que es capaz de sostener en cada momento.
- En **niños mayores y adolescentes**, existen enfoques de modificación del habla y de la tartamudez (estilo Van Riper/Guitar) que combinan técnicas directas con trabajo cognitivo-conductual sobre la actitud ante el habla.

Tu logopeda elegirá el programa adecuado según edad, perfil y factores de riesgo. Si alguien te propone "técnicas sueltas" sin evaluación previa, desconfía.

Actividades en familia (sin presión)

1. Lectura en coro o al unísono. Leed juntos, al mismo tiempo, el mismo texto corto. Al hablar al unísono con otra persona, la tartamudez casi desaparece. Es una experiencia de éxito para el niño.

2. Cantar juntos. El canto utiliza circuitos cerebrales distintos al habla espontánea y casi nunca provoca tartamudez. Además de terapéutico, es divertido y crea conexión.

3. Juego simbólico y roles. Jugad a tiendas, al médico, a restaurantes. La situación de juego genera menos presión que la conversación real, permite practicar el habla en contexto y potencia el lenguaje.

4. Ritmo de conversación lento, modelado por el adulto. En lugar de pedirle al niño que "respire" o "hable despacio", **eres tú quien habla un poco más pausado, con frases cortas y pausas naturales**. El niño se contagia del ritmo sin órdenes explícitas. Nota: esto sustituye al clásico "ejercicio de respiración diafragmática previo a hablar" de muchas guías: pedirle al niño que respire antes de hablar colisiona con el "no le digas respira hondo" de la sección anterior, y además aumenta la autoconciencia.

5. Frases cortas primero, sin corregir. En conversación cotidiana, estructura tus preguntas para que sus respuestas puedan ser breves ("¿Qué quieres, manzana o pera?"). Cuando esté más relajado, emergerán naturalmente frases más largas.

6. Momento de hablar diario, 10 minutos. Antes de dormir, sin pantallas, sin prisas: cada uno cuenta algo de su día. Un espacio seguro, sin evaluación.

7. Preparación anticipada para situaciones exigentes. Si va a haber visita de familiares, cumpleaños, o una exposición en clase, anticipa con él qué va a pasar y qué le puede ayudar. La previsibilidad reduce la ansiedad.

8. Reducir exigencias simultáneas. Evitad las conversaciones cruzadas a la hora de comer, los turnos de habla atropellados y los "cuéntale al abuelo lo que has hecho hoy" frente a la familia. No es prohibido; es elegir bien los momentos.

Consejos generales para estas actividades

- **Diariamente y breve:** 5–10 minutos bien hechos valen más que una sesión larga a la semana.
- **Forma de juego, no de terapia.** Si parece deberes, el niño se resistirá.
- **Modela tú primero.** Haz tú la actividad antes de invitarle a participar.
- **No corrijas** si tartamudea durante el juego. El objetivo es la experiencia positiva de comunicación, no la fluidez perfecta.
- **Celebra el proceso, no la perfección.** "¡Qué bien lo hemos pasado!" es mejor que "¡Qué bien has hablado!".
- **Busca el mejor momento:** descansado, relajado, no después de un día agotador ni a última hora muy tarde.

Capítulo 6 · Sección para profesores

Puedes compartir esta sección con los profesores de tu hijo o hija. Son pautas sencillas, alineadas con la evidencia, que marcan una gran diferencia en el aula.

Pautas para el aula

1. **No forzar la lectura en voz alta** delante de toda la clase. Ofrecer la opción. Leer en privado al profesor puede ser una alternativa válida.
2. **Dar tiempo extra para responder.** No mires el reloj ni muestres impaciencia. Si se bloquea, reformula con una pregunta más cerrada, pero nunca termines su frase.
3. **No interrumpir ni completar sus frases.** Dejar que acabe a su ritmo, aunque tarde.
4. **No evaluar la fluidez.** En exposiciones orales se evalúa contenido, preparación y creatividad, nunca cómo sale el habla.
5. **Ubicación en el aula.** Sentarle donde se sienta cómodo; preguntarle en privado.
6. **Conversación privada** con el alumno sobre sus necesidades. Preguntarle qué le ayuda y qué le resulta difícil. Hacerle partícipe de las decisiones.
7. **Adaptar las presentaciones orales:** presentar en grupo, grabar un vídeo, apoyo visual abundante, o presentar sólo ante el profesor.
8. **Coordinarse con la familia y, si existe, con el logopeda.** Consistencia entre casa, colegio y consulta acelera los resultados.

Crear un aula segura

- Trabajar el respeto a los turnos de habla con todos los alumnos.
- **No tolerar burlas ni imitaciones.** Intervención inmediata.

- Incorporar actividades de educación emocional que trabajen empatía y diversidad comunicativa.
- Si el alumno lo desea, hablar con la clase sobre la tartamudez de forma normalizada.

> **Para el profesor:** un niño que tartamudea puede tener muchísimo que aportar. No le definas por su tartamudez: busca sus fortalezas y poténcialas. Tu actitud marca la diferencia entre un alumno que se apaga y uno que florece.

Capítulo 7 · Cuándo consultar con un logopeda

Consulta con un logopeda especializado en fluidez si se da **cualquiera** de estas señales:

- La disfluencia dura **más de 6 meses**.
- Aparecen **repeticiones de sonido, prolongaciones o bloqueos con tensión** (no solo repeticiones de palabra entera).
- El niño muestra **frustración, tristeza o enfado** por su forma de hablar.
- Se observa **tensión visible** en cara, cuello o cuerpo al hablar.
- **Evita hablar**, responde con monosílobos o deja de participar.
- Aparecen **conductas secundarias**: parpadeo, movimientos de cabeza, muletillas, cambio de palabras.
- La tartamudez **va a más** en lugar de a menos.
- Hay **antecedentes familiares** de tartamudez persistente.
- El niño tiene **más de 5 años** y sigue tartamudeando.
- **Otros niños se burlan** o sufre socialmente.
- **Tú estás preocupado/a.** Tu instinto cuenta.

¿Qué hará el logopeda?

Evaluará el tipo y la severidad de la tartamudez, los factores de riesgo, y el impacto comunicativo y emocional. Con esa información diseñará un plan que, según edad y perfil, puede incluir:

- **Lidcombe** o **Palin PCI** en preescolares.
- **RESTART-DCM** u otros enfoques de demandas y capacidades.
- Modificación del habla y de la tartamudez en niños mayores y adolescentes.
- Pautas detalladas para la familia.
- Coordinación con el colegio.
- Seguimiento periódico.

¿Cuánto dura la intervención?

Depende del caso. Algunos niños mejoran sustancialmente en pocos meses; otros necesitan seguimiento más largo. La evidencia es muy clara en una cosa: **la intervención temprana tiene los mejores resultados**. Cuanto antes se empiece, mayor la probabilidad de recuperación completa.

Capítulo 8 · Recursos y dónde encontrar ayuda

Libros para familias

- **"Tartamudez: guía para padres"** — Fundación Española de la Tartamudez. Práctico y accesible.
- **"El niño que tartamudea"** — J. Scott Yaruss & Nina Reardon-Reeves. Guía para familias basada en evidencia.
- **"Stuttering: Its Nature, Diagnosis and Treatment"** — Barry Guitar. Referencia clínica de consulta para profesionales.
- **"Stuttering: Foundations and Clinical Applications"** — Ehud Yairi & Carol Seery. Referencia académica completa.

Webs y asociaciones

- **Fundación Española de la Tartamudez (TTM):** fundacionttm.org
- **The Stuttering Foundation of America:** stutteringhelp.org (inglés y español)
- **Michael Palin Centre for Stammering** (Londres): creadores del Palin PCI.
- **Lidcombe Program Trainers Consortium:** lidcombeprogram.org
- **ISAD (International Stuttering Awareness Day):** isastutter.org

Para niños

- **"A veces las palabras se atascan"** — libro ilustrado para niños que tartamudean.
- **Personas públicas que tartamudean o tartamudearon** y hablan de ello: Ed Sheeran, Joe Biden, Emily Blunt, Samuel L. Jackson. Son modelos útiles para adolescentes.
- **Películas:** "El discurso del rey" (2010); "Rocket Science" (2007).

Carta a las familias

La tartamudez puede generar preocupación, frustración y, a veces, culpa. Queremos decirte algo importante: **no es culpa tuya**, y hay mucho que puedes hacer para ayudar.

Tu hijo/a necesita sentir que lo que dice importa más que cómo lo dice. Necesita un hogar donde hablar sea seguro, sin prisa ni juicio. Con el apoyo adecuado, la mayoría de los niños

mejora significativamente. Y los que mantienen cierto grado de tartamudez pueden aprender a comunicarse con confianza y sin miedo.

En **Espacio Lenguaje** somos logopedas especializados en fluidez infantil. Si necesitas orientación, estamos a tu lado.

Tu hijo/a tiene voz. Ayúdale a usarla.

Referencias

- **Yairi, E., & Ambrose, N. G.** (1999). Early childhood stuttering I: Persistency and recovery rates. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 42(5), 1097–1112.
- **Yairi, E., & Ambrose, N. G.** (2005). *Early Childhood Stuttering: For Clinicians By Clinicians.* Pro-Ed.
- **Yairi, E., & Ambrose, N. G.** (2013). Epidemiology of stuttering: 21st century advances. *Journal of Fluency Disorders*, 38(2), 66–87.
- **Onslow, M., Packman, A., & Harrison, E.** (eds.). *The Lidcombe Program of Early Stuttering Intervention: A Clinician's Guide.* Pro-Ed. [Programa Lidcombe.]
- **Kelman, E., & Nicholas, A.** *Practical Intervention for Early Childhood Stammering: Palin PCI Approach.* Speechmark. [Palin Parent–Child Interaction.]
- **Guitar, B.** (2019). *Stuttering: An Integrated Approach to Its Nature and Treatment* (5ª ed.). Wolters Kluwer.
- **Singer, C. M., Hessling, A., Kelly, E. M., Singer, L., & Jones, R. M.** (2020). Clinical characteristics associated with stuttering persistence: A meta-analysis. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 63(9), 2995–3018.
- **Reilly, S., Onslow, M., Packman, A., et al.** (2009). Predicting stuttering onset by the age of 3 years: A prospective, community cohort study. *Pediatrics*, 123(1), 270–277.
- **The Stuttering Foundation** — stutteringhelp.org
- **Franken, M. C., & Laroes, E.** RESTART-DCM Method. [Rotterdam Evaluation Study of Stuttering Therapy – Demands and Capacities Model.]

Guía elaborada por Espacio Lenguaje · Logopedia infantil especializada, supervisada por logopeda colegiada. Documento divulgativo basado en evidencia; no sustituye la valoración clínica individual.

E

Más recursos en espaciolenguaje.com

Blog clínico · Guías descargables · Pack Completo con todos los recursos del equipo.

© Espacio Lenguaje · Uso personal. No redistribuir.